

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y BIENESTAR INTEGRAL:

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Departamento:
Prospectiva y Oportunidades

Participantes:

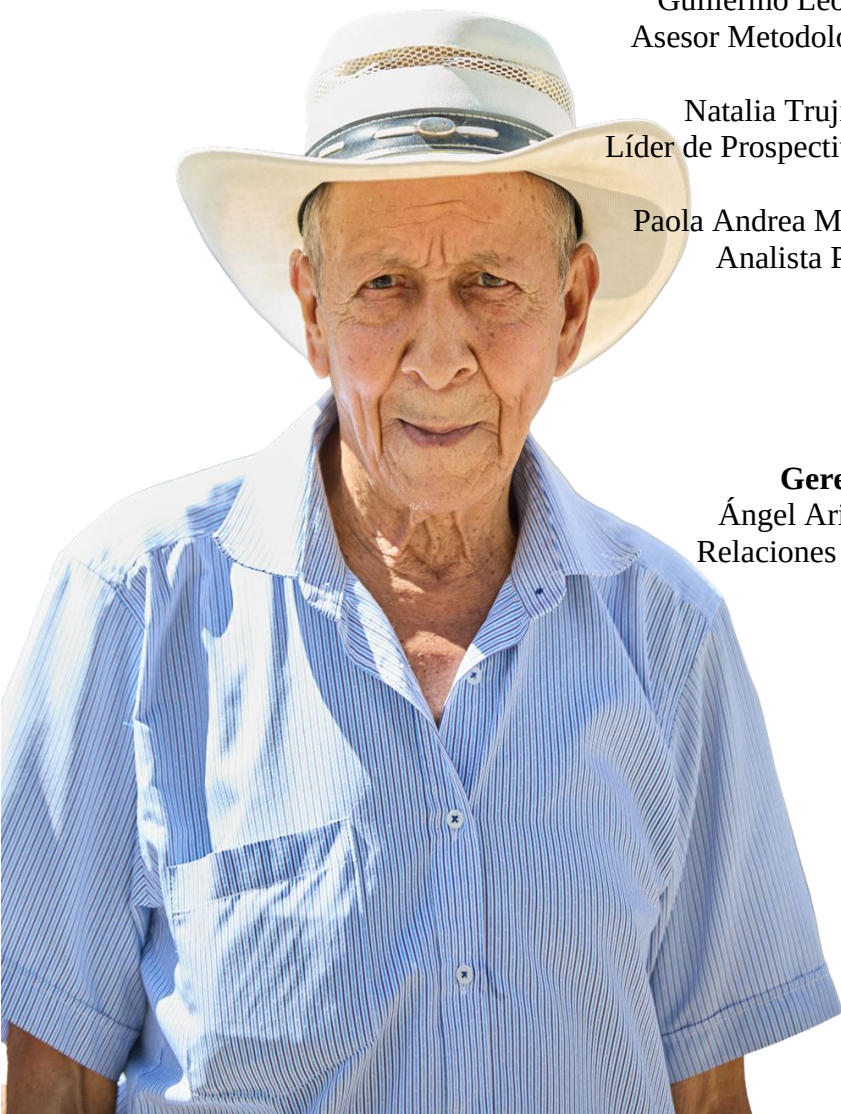
Guillermo León Moreno Soto
Asesor Metodológico Prospectiva

Natalia Trujillo Gonzalez
Líder de Prospectiva y Oportunidades

Paola Andrea Montoya Echeverri
Analista Prospectiva

Gerencia:
Ángel Arias Arango
Relaciones Estratégicas

Esta
HISTORIA
también es **tuya**



1. INTRODUCCIÓN

La transición demográfica es una de las transformaciones estructurales de mayor inercia que enfrentan Colombia y Antioquia en las próximas décadas, y una de las que más condicionan el bienestar de las personas a lo largo de su vida. A diferencia de otras fuerzas de cambio, los desplazamientos demográficos pueden describirse con relativa confianza en horizontes de veinticinco años, porque obedecen a tendencias pesadas con fuerte inercia (de Jouvenel, s. f.; Lang et al., 2026). Sin embargo, esa previsibilidad contrasta con la incertidumbre sobre sus consecuencias para el bienestar, que dependen de decisiones institucionales, arreglos familiares, trayectorias laborales y capacidades territoriales todavía abiertas. En este contexto, la vigilancia prospectiva requiere unidades de análisis capaces de traducir tendencias globales y regionales en implicaciones concretas para el bienestar de las personas, los hogares y las comunidades. La unidad de envejecimiento poblacional responde a esa necesidad, en un país que envejece con rapidez y con desigualdades territoriales marcadas.

El objetivo del documento es producir un análisis de riesgos y de oportunidades sobre el envejecimiento poblacional, leídos desde las dimensiones del bienestar integral y desde sus implicaciones para las políticas públicas y las instituciones sociales. El horizonte temporal adoptado es 2040, esta elección de 2040 obedece a dos razones analíticas: por una parte, las proyecciones disponibles sitúan hacia 2036 el momento en que la población de sesenta años o más superaría a la población menor de quince años en Colombia; por otra, la cohorte que en 2025 tiene entre cuarenta y cincuenta y nueve años llegará en ese periodo a la edad de retiro, lo que abre una ventana corta para intervenir sus trayectorias de protección. El alcance es departamental, con lectura nacional y regional como contexto, y el enfoque privilegia la utilidad estratégica sobre la exhaustividad descriptiva, sin renunciar a la trazabilidad de cada afirmación.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 El bienestar integral como marco de lectura

El bienestar integral se entiende aquí como un estado multidimensional, centrado en las personas, que depende de aquello que efectivamente logran ser y hacer dadas las oportunidades reales disponibles en su territorio. Esta comprensión se ancla en el enfoque de capacidades y desarrollo humano, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2025b) reafirma al recomendar invertir en las capacidades que cuentan y evaluar los avances por sus resultados y no por los medios movilizados. Esta definición tiene tres consecuencias para el análisis del envejecimiento. En primer lugar, desplaza la atención desde los medios, como el ingreso, hacia los logros efectivos, como estar saludable, educado o ser capaz de disfrutar. En segundo lugar, reconoce a cada persona como agente de su propia vida, lo que resulta incompatible con una lectura de la vejez como carga pasiva. En tercer lugar, introduce el territorio como condición de los logros.

De esa comprensión se derivan tres atributos que orientan el análisis desarrollado en esta unidad. El primero es el carácter colectivo del bienestar, entendido como un logro alcanzable por todas las personas en igualdad de derechos y equidad de oportunidades, criterio que obliga a examinar cómo se distribuyen las oportunidades entre grupos y territorios. El segundo es la centralidad de las personas, que exige valorar los logros de cada integrante de los hogares y no solo los promedios agregados. El tercero es la integralidad, que reconoce la interdependencia entre ingresos, empleo, vivienda, salud física y mental, educación, disfrute, vínculos sociales y seguridad del entorno. Para organizar el análisis, estas dimensiones se agrupan en tres ámbitos: las condiciones materiales de vida, la salud física y emocional, y la vida social y educativa. Este anclaje evita que la unidad de análisis se limite a la dimensión pensional o sanitaria del envejecimiento y permite examinar sus efectos simultáneos.

2.2 Envejecimiento, curso de vida y bienestar

El enfoque de curso de vida permite interpretar la transición demográfica como una recomposición de la estructura por edades, en la que cada etapa presenta necesidades, capacidades, riesgos y demandas institucionales diferenciadas. Desde esta perspectiva, la vejez no comienza a los sesenta años, sino que se construye a lo largo de trayectorias educativas, laborales, familiares y de salud acumuladas durante décadas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2026) complementa esta lectura con dos conceptos clave. El primero es el envejecimiento del envejecimiento, es decir, el crecimiento más acelerado del grupo de ochenta años o más, con predominio femenino y mayores niveles de dependencia. El segundo es el fin del bono demográfico, momento en el que la población en edad de trabajar deja de crecer más rápido que la población dependiente. Ambos conceptos son relevantes, porque vinculan el cambio demográfico con la sostenibilidad de la protección social, la organización del cuidado y la capacidad contributiva de los hogares.

El envejecimiento tampoco puede leerse únicamente como un problema. De Jouvenel (s. f.) advierte que la edad fisiológica ya no coincide con la edad cronológica, pues una persona de setenta y cinco años puede encontrarse hoy en condiciones de salud impensables hace algunas décadas, lo que transforma los ciclos de vida, los modos de vida y las relaciones familiares. En la misma dirección, la Dubai Future Foundation (2026) sostiene que la promesa de la longevidad solo se realiza si la innovación se orienta por la calidad de vida y el acceso equitativo, y no únicamente por la extensión de la vida. Esta doble lectura, que reconoce presiones y potencialidades, es coherente con la comprensión del bienestar como estado evaluativo de los logros que las personas alcanzan. Por ello, el marco adoptado combina tres lentes: la demográfica, que dimensiona la magnitud del cambio; la de derechos y capacidades, que examina la calidad de vida en la vejez; y la territorial, que reconoce trayectorias diferenciadas según el lugar donde se envejece.

3. LECTURA DE VIGILANCIA: TENDENCIAS Y SEÑALES

3.1 Una tendencia pesada: el envejecimiento acelerado en Colombia

Entre 2000 y 2025, la población colombiana creció 35,6%, pero de forma desigual entre grupos de edad. La primera infancia disminuyó 13,8%, mientras la población de sesenta años o más aumentó 150,1%, al pasar de 3,16 a 7,91 millones de personas. Los indicadores de envejecimiento confirman la magnitud del cambio. La proporción de personas mayores pasó de 6,9% en 1985 a 14,9% en 2025 y se proyecta en 24,6% para 2050, lo que significa que una de cada cuatro personas tendría sesenta años o más. El índice de envejecimiento subió de 19,5 a 67,3 personas mayores por cada cien menores de quince años entre 1985 y 2025, superaría el umbral de cien hacia 2036 y alcanzaría 180,6 en 2050. La relación de dependencia de personas mayores pasaría de 23,7 a 39,8 por cada cien personas de quince a cincuenta y nueve años entre 2025 y 2050, con una feminización progresiva de la vejez (Comfenalco Antioquia, 2026).

3.2 Antioquia: una economía grande ante una base de soporte que se estrecha

Antioquia muestra una señal demográfica de alta presión. Frente a 2018, su población total crecería alrededor de 9,4%, pero el grupo menor de veinte años se reduciría en más de 812.000 personas y el de sesenta años o más aumentaría en más de 1,04 millones. El dato más sensible es la relación de soporte: por cada cien personas de veinte a cincuenta y nueve años, el departamento pasaría de tener cerca de veintiséis personas mayores a algo más de cincuenta. Esta presión ocurre en el territorio con el segundo mayor producto interno bruto departamental del país, cuya herencia productiva ya no podrá apoyarse en una base joven abundante, sino en productividad, formalización, educación continua y retención de talento subregional. La pregunta estratégica, no es solo de cuántas personas llegarán a la vejez, sino cuántas lograrán acumular trayectorias laborales formales suficientes para pensionarse. En consecuencia, la formalización laboral adquiere el carácter de política anticipada de protección en la vejez.

3.3 Envejecimiento del envejecimiento, dependencia y cuidados

En América Latina y el Caribe, la fecundidad se situó en 1,8 hijos por mujer en 2024 y el porcentaje de personas de sesenta años o más pasaría de 14,5% en 2025 a 25,1% en 2050, con el grupo de ochenta años o más como el de mayor crecimiento (CEPAL, 2026). Este envejecimiento del envejecimiento eleva la demanda de cuidados de largo plazo: la Organización Panamericana de la Salud estimó que al menos ocho millones de personas mayores de la región necesitaban cuidados en 2024, cifra que podría triplicarse y llegar a veintitrés millones en 2050 (Organización Panamericana de la Salud, 2024, como se citó en CEPAL, 2026). Además, la carga total de cuidados, descendente desde la década de 1960, volvería a crecer a partir de 2030. En Colombia, la prevalencia de la discapacidad en la

población de ochenta años o más duplica la del grupo de sesenta a setenta y nueve años, lo que anticipa presiones sobre la salud, el cuidado y la protección social.

3.4 Familias, género, trabajo y protección social

Las estructuras familiares que han absorbido el cuidado se transforman. El tamaño medio de los hogares de la región disminuyó de 4,3 a 3,3 personas entre 2000 y 2024, los hogares unipersonales casi se duplicaron y aumentaron los monoparentales con jefatura femenina (CEPAL, 2026). Las mujeres dedican entre dos y tres veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, lo que limita su autonomía económica y su capacidad de cotizar. A ello se suma una protección social contributiva con baja cobertura, pues la alta informalidad impide que más de la mitad de las personas ocupadas de la región coticen a los sistemas de pensiones, y la informalidad laboral alcanzó 46,6 % del empleo en 2024 (CEPAL, 2025). El análisis de cuentas nacionales de transferencias añade un matiz decisivo para Colombia: en 2021, las transferencias públicas orientadas a la vejez beneficiaron preferentemente a los estratos altos, favorecidos por sistemas contributivos fragmentados que excluyen a quienes tienen trayectorias laborales precarias (Mejía-Guevara et al., 2025, como se citó en CEPAL, 2026).

3.5 Señales emergentes y percepción de riesgos

El corpus registra, además, señales emergentes. Beca (2026) documenta, para el caso francés, la situación de padres de edad avanzada que son únicos cuidadores de hijos adultos con discapacidad, una emergencia no anticipada y estadísticamente poco visible. En Colombia, la Encuesta de Opinión Ejecutiva del WEF (2026) ubica el deterioro de la salud y el bienestar como el primer riesgo nacional percibido, seguido por la falta de oportunidades económicas o desempleo. El mismo informe reconoce la bifurcación demográfica como fuerza estructural del panorama global y señala a los trabajadores de mayor edad entre los grupos que requieren apoyo específico frente a los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Por su parte, Lasso-Valderrama y Vargas (2026) muestran que uno de cada cinco jóvenes colombianos de quince a veinticuatro años no estudia ni trabaja, condición persistente que reduce la ocupación veinte años después. Esta señal conecta el presente juvenil con la vejez futura, porque debilita las trayectorias contributivas de cohortes que envejecerán después de 2050.

Tabla 1

Indicadores clave de la transición demográfica para la unidad de análisis

Indicador	Valor	Territorio
Población de 60 años o más (2000 → 2025)	3,16 → 7,91 millones	Colombia
Proporción de personas de 60 años o más (2025 → 2050)	14,9 % → 24,6 %	Colombia
Índice de envejecimiento (2025 → 2050)	67,3 → 180,6	Colombia

Indicador	Valor	Territorio
Personas mayores por cada 100 personas de 20 a 59 años (2018 → 2050)	$\approx 26 \rightarrow > 50$	Antioquia
Variación de la población menor de 20 años (2018 → 2050)	> -812.000	Antioquia
Proporción de personas de 60 años o más (2025 → 2050)	14,5 % → 25,1 %	América Latina y el Caribe
Personas mayores que requieren cuidados (2024 → 2050)	8 → 23 millones	América Latina y el Caribe
Tamaño medio de los hogares (2000 → 2024)	4,3 → 3,3 personas	América Latina y el Caribe
Informalidad laboral (2024)	46,6 %	América Latina y el Caribe
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan	1 de cada 5	Colombia

Nota. Elaboración propia. Las cifras de Colombia y Antioquia provienen de cálculos con proyecciones del DANE reportados en la fuente citada; OPS = Organización Panamericana de la Salud.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Un riesgo se entiende, como un evento o proceso plausible que podría reducir las oportunidades reales de las personas para alcanzar estados valiosos de bienestar a lo largo del envejecimiento, o que podría debilitar la capacidad de las instituciones para acompañarlo. Esta definición es coherente con el enfoque de capacidades, porque no se limita a la pérdida de medios materiales, sino que incluye el deterioro de los logros efectivos en salud, vínculos, aprendizaje, disfrute y seguridad. Los riesgos se organizan según tres ámbitos del bienestar y se complementan con un grupo de riesgos institucionales y sistémicos de carácter transversal. Para cada riesgo se describen sus mecanismos, la evidencia disponible y su relevancia para la población. Esta organización busca evitar lecturas sectoriales del envejecimiento. La tabla 2 resume la valoración cualitativa de probabilidad, impacto y horizonte, junto con la base de evidencia, para facilitar su priorización y calibración con expertos y actores territoriales.

4.1 Riesgos en el ámbito de las condiciones materiales de vida

El primer riesgo (R1) es la insuficiencia de ingresos y de protección económica en la vejez. En Antioquia, la duplicación proyectada de la relación entre personas mayores y población de veinte a cincuenta y nueve años compromete la lógica intergeneracional del régimen público de pensiones, cuyo acceso depende de la edad y de las semanas cotizadas (Comfenalco Antioquia, 2026). En el ámbito regional, la falta de cobertura y la insuficiencia de las pensiones obligan a muchas personas mayores a permanecer activas para sobrevivir, con frecuencia en condiciones de informalidad (CEPAL, 2026). Este riesgo no se limita a quienes nunca tuvieron empleo formal, pues también alcanza a trabajadores con trayectorias intermitentes que alternan periodos de formalidad e informalidad y que, en consecuencia, no logran completar los requisitos de pensión. Sus efectos se extenderían a las dimensiones de ingresos, gastos y deuda, vivienda y salud, y podrían trasladar a los hogares de los trabajadores activos una parte creciente del sostenimiento económico de sus familiares mayores.

El segundo riesgo (R2) es el empobrecimiento y la sobrecarga de los hogares que cuidan. La CEPAL (2026) señala que el aprovechamiento del bono de género, entendido como el aumento de la participación laboral femenina, se ve obstaculizado por la crisis de los cuidados, y que la sobrecarga de trabajo no remunerado limita la autonomía económica de las mujeres y su capacidad de cotizar. A medida que crece la población de ochenta años o más y se reducen el tamaño de los hogares y el número de hijos, la responsabilidad del cuidado tiende a concentrarse en menos personas, principalmente mujeres en edades productivas. En el plano laboral, se expresa en trabajadoras que podrían reducir su jornada, retirarse del empleo formal o deteriorar su salud mental por la doble carga. Es un riesgo con efecto de arrastre: las mujeres que hoy interrumpen su trayectoria laboral para cuidar tienen mayor probabilidad de convertirse, en el futuro, en personas mayores con pensiones insuficientes, lo que reproduce la desigualdad de género entre generaciones.

El tercer riesgo (R3) es la erosión de la base contributiva y del apoyo intergeneracional futuro. Antioquia perdería más de 812.000 personas menores de veinte años entre 2018 y 2050 (Comfenalco Antioquia, 2026), y en la región el bono demográfico terminaría en 2028 según el promedio proyectado (CEPAL, 2026). Esta contracción relativa se agrava por la calidad de las trayectorias juveniles. Lasso-Valderrama y Vargas (2026) muestran que la condición de no estudiar ni trabajar entre los dieciséis y los veintidós años condiciona la trayectoria laboral, con menor ocupación y mayor desempleo veinte años después, especialmente en los hombres, y menor ocupación asalariada entre las mujeres. En términos prospectivos, cohortes juveniles más pequeñas y con trayectorias frágiles significarían menos aportes para sostener la protección social y menos capacidad familiar para cuidar a sus mayores. La migración podría moderar temporalmente este efecto, como sugieren Luksha (2023) y la CEPAL (2026), pero solo si se acompaña de formalización e inclusión socioeconómica de las personas migrantes.

4.2 Riesgos en el ámbito de la salud física y emocional

El cuarto riesgo (R4) es el aumento de la dependencia funcional y de la demanda de cuidados de largo plazo. Con la edad aumentan las enfermedades crónicas y la coexistencia de varias condiciones de salud, y en las edades más avanzadas se observan síndromes geriátricos, menor autonomía y mayor discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2025, como se citó en CEPAL, 2026). La CEPAL (2026) advierte que el aumento de la esperanza de vida no siempre se acompaña de años vividos con buena salud, y que la demanda de cuidados de largo plazo en la región podría triplicarse hacia 2050. Este riesgo compromete las dimensiones de salud física, integridad física y disfrute, y exige más profesionales en geriatría, fisioterapia, terapia ocupacional y psicología geriátrica. La materialización del riesgo significaría más años con limitaciones funcionales, mayor gasto de bolsillo y una demanda de servicios de apoyo que la oferta actual, pública, privada y del subsidio familiar, podría no absorber con la oportunidad requerida.

El quinto riesgo (R5) es la soledad, el aislamiento social y el deterioro de la salud mental en la vejez. La casi duplicación de los hogares unipersonales en la región (CEPAL, 2026) coincide con lo que Bjørnhof et al. (2025) describen como un desplazamiento hacia la hiperindividualización, en el que las estructuras que facilitaban la vida colectiva, como las comunidades religiosas, los sindicatos y las redes locales, pierden centralidad. Entre las condiciones que aumentan con la edad figuran la depresión y la demencia (Organización Mundial de la Salud, 2025, como se citó en CEPAL, 2026). Este riesgo es especialmente relevante porque afecta la salud mental y los vínculos sociales, dimensiones constitutivas del bienestar. Además, la percepción del deterioro de la salud y el bienestar como principal riesgo nacional en Colombia (WEF, 2026) sugiere una preocupación extendida.

4.3 Riesgos en el ámbito social y educativo

El sexto riesgo (R6) es la profundización de la crisis del cuidado y el envejecimiento de los propios cuidadores. Beca (2026) documenta en Francia casos de madres y padres de edad avanzada, únicos cuidadores de hijos adultos con discapacidad intelectual, que enfrentan hospitalizaciones o enfermedades graves sin soluciones de relevo, y estima que entre 300.000 y 350.000 personas mayores con discapacidad presentan discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista o trastornos mentales graves. Aunque se trata de evidencia de otro contexto, la señal es pertinente para Antioquia, porque la reducción del tamaño de las familias y el aumento de la longevidad de las personas con discapacidad hacen plausible una configuración similar, todavía no documentada en el departamento. El riesgo afecta simultáneamente a dos generaciones y a las dimensiones de vínculos sociales, salud mental e ingresos. Su rasgo distintivo es la invisibilidad, ya que estos hogares suelen resolver el cuidado en silencio hasta que una crisis de salud del cuidador principal convierte una situación privada en una emergencia social.

El séptimo riesgo (R7) es la exclusión digital y laboral de los trabajadores mayores, reforzada por el edadismo. El WEF (2026) recomienda focalizar el apoyo en grupos de alto riesgo frente a los impactos de la inteligencia artificial en el empleo, entre ellos los trabajadores de mayor edad, y advierte que cada año de inacción amplía la brecha de adaptación. The Millennium Project (2019) plantea que la educación en ciencia y tecnología resulta insuficiente frente al desempleo estructural asociado a tecnologías futuras, y propone aprendizaje a lo largo de la vida. A su vez, Bjørnhof et al. (2025) señalan que la conectividad se ha convertido en condición por defecto para acceder a pagos, trabajo y salud, de modo que quienes carecen de acceso constante arriesgan exclusión económica y social. Con una fuerza laboral que envejece, este riesgo afectaría la educación, el empleo y los ingresos, y podría expulsar prematuramente del empleo formal a trabajadores cuya permanencia resulta necesaria para completar sus requisitos de pensión.

4.4 Riesgos institucionales y sistémicos

El octavo riesgo (R8) es el desajuste entre la oferta institucional de servicios sociales y la nueva estructura de edades de la población. Buena parte de los sistemas de protección y de los servicios de bienestar se diseñó alrededor del empleo formal y de hogares en etapas de conformación familiar y crianza, en un contexto en el que la población joven que ingresa al mercado laboral disminuirá en términos relativos y aumentarán los trabajadores mayores, las personas pensionadas y quienes cuidan. Si esa arquitectura no se revisa, podría perder pertinencia frente a demandas crecientes de cuidado, salud preventiva, preparación para el retiro y vínculos en la vejez. El riesgo se formula como inferencia analítica y no como diagnóstico de una oferta específica. Su relevancia radica en que la adaptación institucional exige anticipar los cambios en la composición de los públicos atendidos; de lo contrario, la brecha entre oferta y necesidades se ampliaría sin señales visibles en el corto plazo.

El noveno riesgo (R9) es la invisibilidad estadística y el déficit de capacidades anticipatorias.

La CEPAL (2026) identifica el fortalecimiento de los sistemas de información como primer eje de acción prioritaria, porque la producción de datos desagregados es condición para detectar desigualdades y dimensionar la demanda futura de servicios. Beca (2026) muestra, en el caso francés, que el subgrupo de personas mayores con discapacidad intelectual es el menos documentado, pese a su alta vulnerabilidad. En el plano institucional, Vargas Lama y Melo Rodrigues (2024) encuentran que el pensamiento de largo plazo en los gobiernos latinoamericanos es, en general, incipiente, ya que la mayoría de las economías analizadas se ubica en la categoría más básica o no alcanza clasificación. Este riesgo implica decidir con promedios departamentales que ocultan diferencias subregionales, de género y de condición de discapacidad, y reaccionar tardíamente ante problemas que ya estaban en curso. Se trata de un riesgo amplificador, porque su materialización incrementa la probabilidad y el impacto de los demás riesgos identificados.

El décimo riesgo (R10) corresponde a los riesgos compuestos, que resultan de la interacción entre el envejecimiento y choques externos. El WEF (2026) identifica la confrontación geoeconómica como principal riesgo global de corto plazo y los eventos climáticos extremos como principal riesgo a diez años, mientras que la desaceleración económica figura entre los cinco primeros riesgos percibidos para Colombia. Bjørnhof et al. (2025) destacan, por su parte, la interconexión entre el colapso de ecosistemas y la salud, que se expresa en enfermedades asociadas al calor y en la expansión de enfermedades transmitidas por vectores. La conjunción de estos choques con el envejecimiento es una conjetura prospectiva, pero plausible: las personas mayores con dependencia funcional, sus cuidadores y los hogares con ingresos insuficientes disponen de menor margen para adaptarse a olas de calor, desastres o crisis económicas, y los presupuestos públicos tienden a desplazarse hacia la atención de emergencias. Estos riesgos compuestos podrían tensionar simultáneamente la demanda de servicios sociales y la capacidad de financiarlos.

4.5 Relaciones complejas y sistémicas entre los riesgos

Los riesgos identificados no operan de manera aislada, sino como un sistema de retroalimentación. El núcleo del sistema se encuentra en la relación entre R1, R2 y R6: la sobrecarga de cuidado reduce la participación laboral y la cotización de las mujeres, lo que reproduce pensiones insuficientes en la siguiente generación de mujeres mayores, quienes a su vez demandarán más cuidado con menos recursos. R3 alimenta este ciclo desde el lado de la oferta de trabajo y de apoyo familiar, mientras R4 y R5 lo intensifican desde la demanda. R7 y R8 son riesgos de adaptación de personas e instituciones a una sociedad más longeva, y R9 opera como amplificador transversal. La lectura sistémica permite concluir que las dos variables que más condicionan la materialización del conjunto de riesgos son la organización social del cuidado y la calidad de las trayectorias económicas de las cohortes que envejecen.

Tabla 2

Matriz de valoración cualitativa de riesgos de la unidad de envejecimiento poblacional

Riesgo	Nodo y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R1. Insuficiencia de ingresos y protección en la vejez	Material: ingresos, empleo, vivienda	Alta	Alto	Medio y largo
R2. Empobrecimiento y sobrecarga de hogares cuidadores	Material y social: ingresos, salud mental, vínculos	Alta	Alto	Corto y medio
R3. Erosión de la base contributiva y del apoyo intergeneracional	Material: empleo, ingresos	Alta	Alto	Largo
R4. Dependencia funcional y demanda de cuidados de largo plazo	Salud física y emocional: salud física, integridad, disfrute	Alta	Alto	Medio
R5. Soledad, aislamiento y salud mental	Salud física y emocional: salud mental, vínculos	Media-alta	Alto	Medio
R6. Crisis del cuidado y cuidadores que envejecen	Social: vínculos, salud mental, ingresos	Media	Alto	Medio
R7. Exclusión digital y laboral y edadismo	Social y educativo: educación, empleo	Media-alta	Medio-alto	Corto y medio
R8. Desajuste de la oferta institucional frente a la estructura de edades	Institucional: transversal	Media	Alto	Largo
R9. Invisibilidad estadística y déficit anticipatorio	Institucional: transversal	Media-alta	Medio	Corto
R10. Riesgos compuestos por choques externos	Sistémico: transversal	Media	Alto	Medio y largo

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares del equipo analítico y deben calibrarse en talleres de validación. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

5. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

Una oportunidad se entiende como un proceso o condición plausible que podría ampliar las libertades y los logros de las personas a lo largo del envejecimiento, o fortalecer la capacidad de las instituciones para acompañarlos. La CEPAL (2026) reconoce que el cambio demográfico también abre oportunidades, entre ellas el bono de género, el potencial aumento de la productividad derivado de invertir más en un número decreciente de estudiantes, las innovaciones tecnológicas y la expansión de sectores que responden a las necesidades de una población más longeva, como salud, cuidados, finanzas, tecnologías digitales, turismo, educación, recreación y vivienda adaptada. No obstante, la misma fuente advierte que, en una región con alta informalidad, baja cobertura previsional y acceso desigual a servicios sociales, esas oportunidades deben evaluarse con una lógica inclusiva distinta de la de regiones más desarrolladas. Este apartado adopta esa advertencia como criterio: una oportunidad solo se considera tal si su aprovechamiento amplía oportunidades reales para el conjunto de la población y no solo para los segmentos de mayores ingresos.

5.1 Oportunidades en el ámbito de las condiciones materiales de vida

La primera oportunidad (O1) es la longevidad activa, entendida como la posibilidad de prolongar trayectorias de trabajo decente, emprendimiento y aprendizaje en edades avanzadas por elección y no por necesidad. De Jouvenel (s. f.) observa que la edad fisiológica se ha distanciado de la cronológica, lo que flexibiliza los ciclos de vida. La CEPAL (2026) plantea la necesidad de adaptar los entornos laborales a una fuerza de trabajo de mayor edad y de avanzar hacia modelos de aprendizaje a lo largo de la vida que incluyan a las personas mayores. The Millennium Project (2019), por su parte, propone orientar los sistemas educativos hacia el dominio de habilidades y la autorrealización. Esta oportunidad se conecta con los servicios de educación, empleo y emprendimiento, y podría expresarse en rutas de reconversión para trabajadores de cuarenta y cinco años o más, orientadas a sostener la densidad de cotización que el riesgo R1 pone en cuestión. Su condición habilitante es que las empresas revisen prácticas de contratación etarias.

La segunda oportunidad (O2) es el desarrollo del cuidado como sector dinamizador de la economía y generador de empleo formal. La CEPAL (2026) propone reconocer el cuidado como derecho humano y como inversión social estratégica que, mediante sistemas integrales y financiamiento adecuado, puede generar empleo formal y fomentar la corresponsabilidad entre Estado, mercado, hogares y comunidades. El crecimiento de la demanda de profesionales en geriatría, fisioterapia, terapia ocupacional y psicología geriátrica amplía, además, la necesidad de oferta formativa especializada. Esta oportunidad tiene una doble cara. Por un lado, permite desarrollar formación y certificación de competencias para personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, cuyo trabajo suele ser informal y no reconocido. Por otro lado, abre la posibilidad de articular servicios de apoyo, relevo y respiro para los hogares que cuidan, en alianza con actores públicos y privados. Su aprovechamiento con enfoque de

bienestar exige evitar la precarización del empleo de cuidado, que reproduciría en otro lugar los riesgos R1 y R2.

La tercera oportunidad (O3) es el aprovechamiento del bono de género mediante la corresponsabilidad empresarial en los cuidados. Las mujeres representaban alrededor del 27 % de la fuerza de trabajo latinoamericana en 1980, cerca del 43 % en 2025 y se proyecta que alcancen el 45 % en 2050, lo que indica un avance sin paridad (CEPAL, 2026). La misma fuente destaca que las políticas de conciliación, como las licencias equitativas, la flexibilidad laboral y los servicios de cuidado, permiten superar barreras que impiden a las personas realizar sus proyectos de vida. Esta oportunidad involucra de manera directa a los empleadores, que pueden reconocer y apoyar las responsabilidades de cuidado de sus equipos. En términos operativos, podría traducirse en programas empresariales de apoyo a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades de cuidado de personas mayores, en protocolos de flexibilidad y en indicadores de bienestar que visibilicen esa carga dentro de los planes de gestión humana de las organizaciones.

5.2 Oportunidades en el ámbito de la salud física y emocional

La cuarta oportunidad (O4) es el envejecimiento saludable basado en la prevención y en los determinantes sociales de la salud. La CEPAL (2026) subraya la necesidad de preservar la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores mediante sistemas de salud universales y sostenibles, en consonancia con la propuesta de Marinho y Farías (2026) de situar a las personas y sus derechos en el centro de los sistemas de salud. Bjørnhof et al. (2025) describen un desplazamiento del tratamiento hacia la prevención y de la lucha contra el envejecimiento hacia la optimización de la longevidad, en el que la dieta, la comunidad y el bienestar mental adquieren tanta importancia como la tecnología. Según la Dubai Future Foundation (2026), la longevidad depende también del propósito y el sentido de vida. Esta oportunidad se vincula con los servicios de deporte, hábitos de vida saludable, alimentación, recreación y turismo, que podrían orientarse a preservar la capacidad funcional y prevenir la dependencia.

5.3 Oportunidades en el ámbito social y educativo

La quinta oportunidad (O5) es el fortalecimiento de vínculos intergeneracionales y comunitarios como respuesta a la soledad y a la fragmentación social. Jackson et al. (2024) proponen la equidad intergeneracional como principio de gobernanza para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, y el PNUD (2025a) promueve espacios de colaboración intergeneracional orientados al futuro. Así, la relación entre generaciones puede concebirse como intercambio de saberes, tiempo y cuidado, y no solo como competencia por recursos. La oportunidad se conecta con los servicios de cultura, conocimiento y desarrollo humano y social, y con el reconocimiento de las formas propias en que las comunidades significan una buena vida. Podría materializarse en programas de mentoría entre

trabajadores mayores y jóvenes, en particular jóvenes que no estudian ni trabajan, en redes de voluntariado de personas pensionadas y en espacios culturales compartidos. Responde simultáneamente a los riesgos R3, R5 y R7, y su condición habilitante es el diseño participativo con las propias personas mayores, no para ellas.

La sexta oportunidad (O6) es la adaptación de la vivienda y de los entornos territoriales a una sociedad longeva. La CEPAL (2026) incluye la vivienda y los entornos adaptados entre los sectores que pueden consolidarse como motores de desarrollo en contextos de envejecimiento. Una señal relevante es la herramienta City of Longevity, premiada en el Dubai Future Forum, que usa escenarios de largo plazo para diseñar ciudades adecuadas al bienestar de personas centenarias y recién nacidas (Dubai Future Foundation, 2026). Esta oportunidad se relaciona con la dimensión de vivienda, activos y servicios, y con el reconocimiento de la diversidad territorial como condición del bienestar. Podría expresarse en diseño universal en proyectos habitacionales, mejoramiento de vivienda para hogares con personas mayores y alianzas subregionales para entornos amigables con la edad. Su aprovechamiento requiere reconocer que las necesidades de envejecer en el Valle de Aburrá difieren de las de envejecer en subregiones rurales y dispersas.

5.4 Oportunidades institucionales y de gobernanza

La séptima oportunidad (O7) es la promoción del bienestar financiero y la preparación para el retiro a lo largo del curso de vida. La pregunta departamental sobre cuántas personas lograrán acumular trayectorias suficientes para pensionarse (Comfenalco Antioquia, 2026), convierte la educación y la planeación financiera en un campo pertinente para la dimensión de ingresos, gastos y deuda. Las instituciones financieras y de bienestar, por su relación directa con empresas y trabajadores, pueden intervenir antes de que la ventana de acción se cierre para la cohorte de cuarenta a cincuenta y nueve años. No obstante, el protocolo de sesgos obliga a una advertencia: esta oportunidad no debe interpretarse como sustitución de la protección social pública ni como traslado de la responsabilidad del riesgo de vejez a las decisiones individuales, dado que la CEPAL (2026) insiste en sistemas de protección social universales. Su valor reside en complementar esos sistemas, en particular para trabajadores con ingresos variables, y en evitar el sobreendeudamiento en edades cercanas al retiro.

La octava oportunidad (O8) es la consolidación de capacidades de inteligencia anticipatoria y de gobernanza colaborativa en torno al envejecimiento. La CEPAL (2026) identifica el fortalecimiento de los sistemas de información, la formación técnica, la institucionalidad y la articulación con la sociedad civil como ejes prioritarios, y el WEF (2026) recomienda monitorear los riesgos laborales, sociales y de confianza con la misma rigurosidad con que se vigilan los mercados financieros. Los sistemas de vigilancia prospectiva se encuentran en posición favorable para aprovechar esta oportunidad cuando disponen de mediciones cuantitativas del bienestar de personas, hogares y organizaciones. Integrar a ese modelo variables de envejecimiento, cuidado y trayectorias contributivas,

desagregadas por sexo, edad, subregión y condición de discapacidad, permitiría responder al riesgo R9. Adicionalmente, la promoción de alianzas entre el sector público y el privado habilita mesas territoriales de anticipación sobre envejecimiento con gobiernos locales, universidades, empresas y organizaciones de personas mayores.

5.5 Relaciones complejas y sistémicas entre las oportunidades

Ninguna de las oportunidades identificadas se realiza automáticamente por efecto del cambio demográfico: todas dependen de condiciones institucionales, empresariales y comunitarias. En particular, su aprovechamiento se relaciona con las mismas dos variables que estructuran el sistema de riesgos, a saber, la organización social del cuidado y la calidad de las trayectorias económicas. Las oportunidades O2, O3 y O5 operan principalmente sobre la primera variable, mientras O1, O7 y O8 lo hacen sobre la segunda, y O4 y O6 actúan de manera transversal. Conviene, además, distinguir oportunidades de mercado y oportunidades de bienestar. La llamada economía de la longevidad puede generar crecimiento sin ampliar las oportunidades reales de quienes envejecen con menores ingresos, por lo que cada iniciativa debe evaluarse por su contribución al bienestar colectivo y no solo por su viabilidad comercial. Esta distinción coincide con la advertencia de la Dubai Future Foundation (2026) sobre la necesidad de orientar la longevidad hacia la calidad de vida y el acceso equitativo.

Tabla 3

Matriz de valoración cualitativa de oportunidades de la unidad de envejecimiento poblacional

Oportunidad	Nodo	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O1. Longevidad activa, trabajo decente y aprendizaje a lo largo de la vida	Económico y social	Alto	Corto y medio	Empresas sin prácticas edadistas
O2. Cuidado como sector dinamizador y generador de empleo formal	Económico y social	Alto	Medio	Financiamiento y formalización
O3. Bono de género y corresponsabilidad empresarial	Económico	Alto	Corto y medio	Compromiso del sector empresarial
O4. Envejecimiento saludable y prevención	Físico y emocional	Alto	Medio y largo	Articulación con el sistema de salud
O5. Vínculos intergeneracionales y comunitarios	Social e intelectual	Medio-alto	Corto	Diseño participativo

Oportunidad	Nodo	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O6. Vivienda y entornos para la longevidad	Material: vivienda	Medio-alto	Medio y largo	Alianzas municipales y subregionales
O7. Bienestar financiero y preparación para el retiro	Económico	Medio	Corto	Complementariedad con protección pública
O8. Inteligencia anticipatoria y gobernanza colaborativa	Institucional	Alto	Corto	Datos desagregados y alianzas

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares sujetos a calibración. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

6. CONCLUSIONES

El envejecimiento poblacional es una de las fuerzas de cambio más previsibles del periodo que va hasta 2040, pero sus consecuencias para el bienestar no están determinadas. Los datos disponibles muestran una transición acelerada en Colombia y una presión particularmente intensa sobre la relación de soporte en Antioquia, en un contexto regional marcado por informalidad, crisis de los cuidados, transformación de los hogares y persistencia de desigualdades de género y de clase.

El análisis de riesgos evidencia que estas presiones se refuerzan mutuamente y que el ciclo entre sobrecarga de cuidado, trayectorias laborales interrumpidas y pensiones insuficientes constituye el núcleo del problema. El análisis de oportunidades muestra, sin embargo, que la longevidad puede traducirse en ampliación de capacidades si se acompaña de trabajo decente, cuidado corresponsable, prevención, vínculos intergeneracionales y entornos adaptados. La distancia entre ambos resultados no es demográfica, sino institucional y social, lo que confirma la pertinencia de abordar el envejecimiento desde una comprensión multidimensional del bienestar. La próxima década constituye la ventana de oportunidad, porque las decisiones que se tomen sobre cuidado, formalización y aprendizaje determinarán las condiciones en que la cohorte que hoy se encuentra en plena vida laboral vivirá su vejez.

7. REFERENCIAS

- Beca, F. (2026, 19 de junio). *Cuando los cuidadores envejecen junto con sus hijos con discapacidad: una emergencia invisible* [Nota de seguimiento]. Futuribles International.
- Bjørnhof, M. B., Dakinah, K. y Hejselbæk, S. C. (2025). *Megatrends 2025: The global forces of change shaping the futures ahead*. ANTICIPATE. <https://anticipate.dk/megatrends>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). *Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social* (LC/PUB.2025/23-P/-*). Naciones Unidas.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026). *Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública* (LC/CRPD.6/3). Naciones Unidas.
- de Jouvenel, F. (s. f.). *Horizontes 2050: el mundo se enfrenta a sus límites* [Transcripción de conferencia magistral]. Fundación Javier Barros Sierra.
- Dubai Future Foundation. (2026). *Dubai Future Forum 2025: Key insights from the world's largest gathering of futurists*.
- Comfenalco Antioquia. (2026). *Envejecimiento poblacional: caracterización de los grupos etarios en Colombia desde el enfoque de curso de vida* [Documento técnico de trabajo,]. (2026).
- Jackson, A., Fernández, F., Zuzarte Tully, C. y Howe, S. (2024). *Working for the wellbeing of current and future generations: Implementation handbook for the UN Declaration on Future Generations*. School of International Futures.
- Lang, N., Iny, A., Pidun, U., Christensen, M., Sprong, J. y Job, A. (2026). *Beyond tomorrow: Four scenarios for the world of 2050*. BCG Henderson Institute.
- Lasso-Valderrama, F. y Vargas, C. O. (2026). *Jóvenes que ni estudian ni trabajan: dinámica y determinantes en Colombia* (Núm. 1363). Banco de la República.
- Luksha, P. (2023). *The next 100 years: A bridgeway across the decisive century*.
- Marinho, M. L. y Farías, C. (2026). *Sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes: un requisito para el desarrollo social inclusivo*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025a). *Democratizando futuros: herramientas para anticipar y co-crear políticas públicas con juventudes*.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025b). *Informe sobre Desarrollo Humano 2025. Un llamado a decidir: personas y posibilidades en la era de la inteligencia artificial. Panorama general* [Traducción preliminar].
- Schindler, T. y Guadarrama Baena, G. (Eds.). (2021). *Stories from 2050: Radical, inspiring and thought-provoking narratives around challenges and opportunities of our futures*. Foresight on Demand.
- The Millennium Project. (2019, 24 de septiembre). *Resumen ejecutivo* [Estudio Trabajo/Tecnología 2050].

- Vargas Lama, F. y Melo Rodrigues, L. M. (2024). The state of long-term thinking in Latin American governments. En T. Villman, S. Heinonen y L. Pouru-Mikkola (Eds.), *Our world of futures studies as a mosaic: Part 1* (pp. 153–176). The Finnish Society for Futures Studies.
- World Economic Forum. (2026). *The global risks report 2026* (21.^a ed.).
- Zoccarato, F., Lettieri, E. y Toletti, G. (2026). Exploring experts' discourses in corporate foresight: Unveiling the temporal tension between past-present-future. *Futures*, 184, Artículo 103921. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103921>